



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN PELAYANAN
UNIT *CLEANING SERVICE***

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

LEMBAR PENGESAHAN
Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Nomor 571.5/I-PDM/DIR/VI/2025

Tentang
Pedoman Pelayanan Unit Cleaning Service

Disusun oleh :
Penanggung Jawab Unit Cleaning Service



Muhammad Ridzal

Disetujui oleh :
Authorized Person



Dr. dr. Aslichah, M. Kes. AFP

Ditetapkan oleh :

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Nur Mazidah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karuniaNya, tim penyusun dapat menyelesaikan pedoman pelayanan unit Cleaning Service Rumah Sakit Prima Husada.

Pedoman Pelayanan unit Cleaning Service RS Prima Husada Tahun 2025 ini yang mulai dipergunakan pada tahun 2025 meliputi kegiatan pelayanan yang dilakukan di unit Cleaning Service Rumah Sakit Prima Husada.

Kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah berkontribusi di dalam penyusunan pedoman ini. Kami mengharapkan segala saran, kritik dan masukan yang membangun untuk memperbaiki isi dari buku pedoman ini.

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Nur Mazidah

TIM PENYUSUN

PEDOMAN PELAYANAN UNIT CLEANING SERVICE

1. dr. Nur Mazidah
2. drg. Endy Wira Pradana, MMRS
3. Muhammad Ridzal, SE
4. Sherly Rosita, S.Kep., Ns
5. Erik Ardianata
6. Pj mutu Nanda dwiki
7. Pj PPI putri wahyuning
8. Pj kamar jenazah alifia ahmad ageng
9. Pj inventaris cs Yusak dwi santoso
10. Pj B3 alifia ahmad ageng

DAFTAR ISI

JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN ii

KATA PENGANTAR..... iii

TIM PENYUSUN iv

DAFTAR ISI 1

DAFTAR GAMBAR 2

DAFTAR TABEL **Error! Bookmark not defined.**

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA 3

LAMPIRAN..... 5

BAB I 6

PENDAHULUAN 6

1.1 Latar Belakang 6

1.2 Tujuan Pedoman 6

1.3 Ruang Lingkup Pelayanan 6

1.4 Batasan Operasional..... 7

BAB II..... 8

STANDAR KETENAGAAN 8

2.1 Kualifikasi Sumber Daya manusia 8

2.2 Distribusi Ketenagaan 8

2.3 Pengaturan Jaga..... 8

BAB III..... 10

STANDAR FASILITAS 10

3.1 Denah Ruang..... 10

3.2 Standar Fasilitas 10

3.3 Pemeliharaan Peralatan **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV 12

TATA LAKSANA PELAYANAN 12

4.1 Tata Laksana Pelayanan Dekontaminasi **Error! Bookmark not defined.**

4.2 Tata laksana pelayanananan Proses Sterilisasi : **Error! Bookmark not defined.**

BAB V 20

LOGISTIK 20

BAB VI 22

KESELAMATAN PASIEN DAN PETUGAS..... 22

BAB VII 24

KESELAMATAN KERJA 24

BAB VIII 27

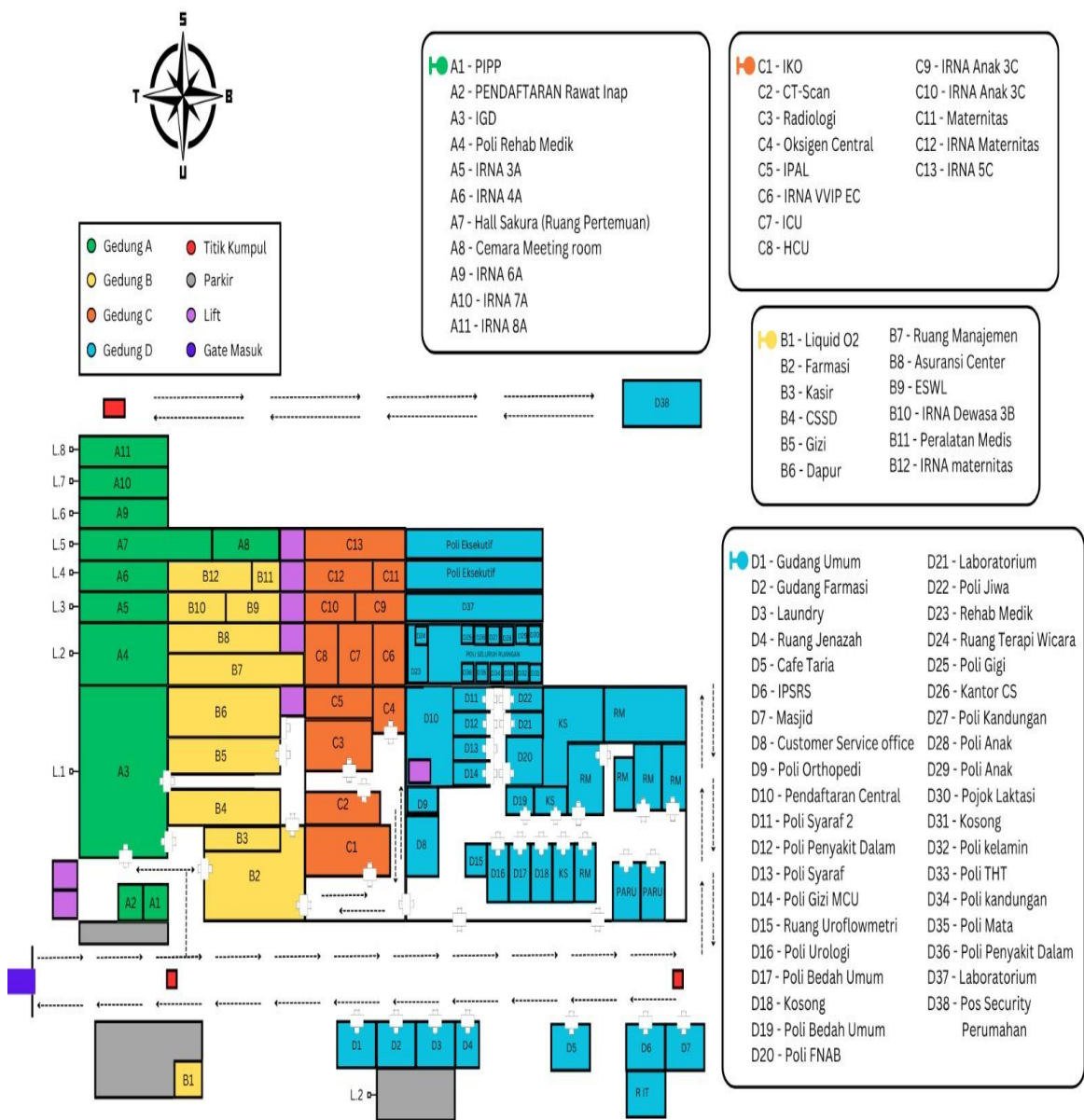
PENGENDALIAN MUTU 27

BAB IX 29

PENUTUP 29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Denah Ruang



**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR : 571.5/I-PDM/DIR/VI/2025**

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN UNIT CLEANING SERVICE

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Prima Husada, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang bermutu tinggi dari setiap instalasi pelayanan yang ada;
- b. bahwa agar pelayanan unit Cleaning Service dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya Peraturan Direktur tentang kebijakan pemberlakuan buku Pedoman Pelayanan Cleaning Service;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur Rumah sakit Prima Husada;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
13. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 390/I-

KEP/DIR/V/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada;

14. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor: 263/DPM/I-KEP/DIR/I/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA TENTANG PEDOMAN PELAYANAN UNIT CLEANING SERVICE RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA.**

Pasal 1

Menetapkan Pedoman Pelayanan Cleaning Service sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan kebersihan, sanitasi lingkungan, dan pengelolaan lingkungan Rumah Sakit Prima Husada.

Pasal 2

- (1) Unit Cleaning Service merupakan unit penunjang rumah sakit yang bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan dan sanitasi lingkungan rumah sakit.
- (2) Unit Cleaning Service berfungsi sebagai pengelola kegiatan kebersihan lingkungan secara terintegrasi.
- (3) Unit Cleaning Service memastikan seluruh area rumah sakit dalam kondisi bersih, aman, dan memenuhi standar kesehatan lingkungan.

Pasal 3

Pedoman pelayanan Cleaning Service sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:

- a. Pembersihan dan desinfeksi lingkungan;
- b. Pengelolaan sampah medis dan non medis;
- c. Pengelolaan linen kotor (handling awal sebelum laundry);
- d. Pengendalian mutu kebersihan lingkungan;
- e. Keselamatan kerja serta pencegahan dan pengendalian infeksi;
- f. Pengelolaan bahan pembersih dan bahan berbahaya dan beracun (B3).

Pasal 4

- (1) Kegiatan Cleaning Service dilaksanakan secara terpusat dan terkoordinasi sesuai dengan pembagian area kerja di rumah sakit.
- (2) Rumah sakit menetapkan kebijakan bahwa seluruh kegiatan pembersihan dan pengelolaan lingkungan dilakukan sesuai standar operasional prosedur yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Cleaning Service meliputi tahapan:
 - a. Persiapan alat dan bahan;
 - b. Penggunaan alat pelindung diri (APD);
 - c. Pembersihan dan desinfeksi permukaan;
 - d. Pengelolaan sampah sesuai jenisnya;
 - e. Pengelolaan tumpahan infeksius dan B3;
 - f. Pembersihan akhir dan pelaporan.
- (4) Pengangkutan sampah dan linen kotor dilakukan menggunakan wadah tertutup sesuai standar.

Pasal 5

Kegiatan Cleaning Service wajib menerapkan prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi, termasuk penggunaan APD sesuai risiko, pelaksanaan pembersihan sesuai teknik yang benar, serta larangan mencampur area bersih dan kotor.

Pasal 6

Unit Cleaning Service wajib melakukan pengendalian mutu kebersihan lingkungan secara berkala melalui monitoring, audit kebersihan, serta pendokumentasian kegiatan yang dapat ditelusuri dan dievaluasi.

Pasal 7

Area yang telah dibersihkan harus dijaga kebersihannya sesuai standar, serta dilakukan pengaturan zonasi area bersih, kotor, dan risiko tinggi guna mencegah kontaminasi silang.

Pasal 8

Pelaksanaan Cleaning Service dilakukan berdasarkan klasifikasi area risiko (risiko tinggi, sedang, dan rendah) dengan metode pembersihan dan desinfeksi yang sesuai untuk menjamin keamanan lingkungan.

Pasal 9

Unit Cleaning Service harus memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi standar, termasuk ketersediaan alat kebersihan, bahan pembersih, APD, serta pengelolaan penyimpanan bahan kimia secara aman.

Pasal 10

Monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan Cleaning Service dilakukan secara berkala dan hasilnya digunakan sebagai dasar peningkatan mutu pelayanan serta dilaporkan kepada manajemen rumah sakit.

Pasal 11

Pedoman pelayanan Unit Cleaning Service merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini, berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dilakukan peninjauan secara berkala sesuai kebutuhan serta perkembangan regulasi.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 5 Juni 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,

dr. Nur Mazidah

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH

SAKITPRIMA HUSADA
NOMOR 571.5/I-PDM/DIR/VI/2025
TENTANG PEDOMAN PELAYANAN
UNIT CLEANING SERVICE

PEDOMAN PELAYANAN UNIT CLEANING SERVICE

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit sebagai institusi penyedia pelayanan kesehatan berupaya untuk mencegah risiko terjadinya infeksi bagi pasien, petugas, dan pengunjung. Salah satu indikator keberhasilan dalam pelayanan rumah sakit adalah terciptanya lingkungan yang bersih, aman, dan mendukung upaya pencegahan serta pengendalian infeksi. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan pengelolaan kebersihan dan sanitasi lingkungan rumah sakit yang optimal dan berkesinambungan.

Unit Cleaning Service merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung upaya pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit. Unit ini berperan dalam menjaga kebersihan lingkungan, melakukan pembersihan dan desinfeksi area pelayanan, serta mendukung pengelolaan limbah dan linen kotor. Dalam pelaksanaannya, Unit Cleaning Service sangat bergantung pada koordinasi dengan unit lain seperti PPI, K3RS, IPSRS, dan unit pelayanan. Apabila terjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan kebersihan, maka dapat berdampak pada meningkatnya risiko infeksi serta menurunnya mutu pelayanan rumah sakit.

Bila ditinjau dari luas area, volume kegiatan pelayanan, serta tingginya mobilitas pasien, petugas, dan pengunjung di rumah sakit, maka diperlukan pengelolaan kebersihan yang terorganisir, terstandar, dan terintegrasi. Unit Cleaning Service bertugas untuk memastikan seluruh area rumah sakit tetap bersih, higienis, dan memenuhi standar kesehatan lingkungan secara tepat, cepat, dan berkesinambungan guna mendukung keselamatan pasien dan mutu pelayanan rumah sakit.

1.2 Tujuan Pedoman

Tujuan pedoman ini adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan Unit Cleaning Service di Rumah Sakit agar kegiatan kebersihan, sanitasi lingkungan, dan pengelolaan lingkungan dapat dilaksanakan secara terarah, terkoordinasi, efektif, dan efisien sesuai dengan standar yang berlaku, serta mendukung upaya pencegahan dan pengendalian infeksi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di rumah sakit.

1.3 Ruang Lingkup Pelayanan

Ruang lingkup pelayanan Unit Cleaning Service meliputi seluruh kegiatan kebersihan dan sanitasi lingkungan rumah sakit, termasuk pembersihan dan desinfeksi area pelayanan dan non pelayanan, pengelolaan sampah medis dan non medis, pembersihan area berisiko tinggi, sedang, dan rendah sesuai klasifikasi, pengelolaan bahan pembersih dan bahan berbahaya dan beracun (B3), serta penerapan prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) dan keselamatan

dan kesehatan kerja (K3RS) dalam setiap kegiatan pelayanan.

1.4 Batasan Operasional

Batasan operasional Unit Cleaning Service meliputi pelaksanaan kegiatan kebersihan dan sanitasi lingkungan rumah sakit yang mencakup pembersihan dan desinfeksi permukaan, pengelolaan sampah medis dan non medis, serta penanganan awal linen kotor sebelum diproses oleh unit laundry. Unit Cleaning Service tidak melakukan tindakan medis, sterilisasi alat kesehatan, maupun pengolahan akhir limbah medis, dan seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur, prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI), serta keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit (K3RS). Selain itu, pelaksanaan kegiatan dibatasi pada area kerja yang telah ditetapkan dengan memperhatikan klasifikasi risiko area serta penggunaan alat, bahan, dan alat pelindung diri sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB II

STANDAR KETENAGAAN

2.1 Kualifikasi Sumber Daya manusia

Kualifikasi tenaga yang bekerja di Unit Cleaning Service Rumah Sakit Prima Husada dibedakan sesuai dengan kapasitas tugas dan tanggung jawabnya, yang terdiri atas Kepala Bagian Umum, Penanggung Jawab (PJ) Cleaning Service, dan Anggota Cleaning Service.

Kepala Bagian Umum:

- 1. Minimal pendidikan S1 (diutamakan bidang manajemen/ administrasi/ kesehatan).
- 2. Memiliki pengalaman manajerial di rumah sakit.
- 3. Memahami pengelolaan fasilitas dan lingkungan rumah sakit.
- 4. Telah mengikuti pelatihan manajemen rumah sakit, K3RS, dan PPI.

Penanggung Jawab (PJ) Cleaning Service:

- 1. Minimal lulusan SMA/ sederajat
- 2. Memiliki pengalaman di bidang cleaning service, khususnya di fasilitas pelayanan kesehatan
- 3. Memahami prinsip kebersihan lingkungan rumah sakit
- 4. Telah mengikuti pelatihan: Cleaning service rumah sakit, Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3RS)

2.2 Distribusi Ketenagaan

Tabel 2.1 Distribusi Ketenagaan

Dinas Pagi	PJ / KaBag	1	Penanggung jawab
			Supervisi monitoring
	Pelaksana	17	membersihkan area irna
			Membersihkan area irja Membersihkan area IKO Membersihkan area Pantry dan dapur Membersihkan area IGD
Dinas Midlle	Pelaksana	1	Membersihkan area masjid
			Membersihkan area B3 dan R vaksin
Dinas Sore	Pelaksana	14	membersihkan area irna
			Membersihkan area irja Membersihkan area IKO Membersihkan area Pantry dan dapur Membersihkan area IGD

2.3 Pengaturan Jaga

Tabel 2.2 Pengaturan Jaga

Jadwal Dinas	Waktu
Dinas Pagi	06.00 s/d 14.00
Dinas Midlle	10.00 s/d 18.00
Dinas Sore	14.00 s/d 22.00
Dinas long shift	07.00 s/d 19.00

BAB III

STANDAR FASILITAS

3.1 Denah Ruang



Gambar 3.1 Denah Ruang

3.2 Standar Fasilitas

Fasilitas Unit Cleaning Service Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan untuk mendukung kegiatan kebersihan, sanitasi lingkungan, serta keselamatan kerja petugas sesuai dengan standar yang berlaku.

1. Ruang dan Area Kerja

Unit Cleaning Service harus memiliki fasilitas ruang sebagai berikut:

- Ruang penyimpanan alat kebersihan (cleaning tools room)
- Ruang penyimpanan bahan kimia dan desinfektan (terpisah dan aman)
- Area pencucian alat kebersihan (mop sink/utility sink)
- Area penyimpanan troli kebersihan
- Tempat penyimpanan APD

2. Peralatan Kebersihan

Peralatan yang harus tersedia meliputi:

- Troli cleaning service (cleaning trolley)
- Mop set (basah dan kering)
- Ember dan alat pel
- Sapu, pengki, dan alat pembersih debu
- Kain lap (dibedakan berdasarkan warna/area)
- Vacuum cleaner (untuk area tertentu)
- Alat pembersih kaca
- Warning sign (tanda lantai basah)

3. Bahan Pembersih dan Desinfektan

- Detergen pembersih lantai
- Desinfektan sesuai standar PPI
- Pembersih kaca
- Pembersih kamar mandi
- Bahan pembersih khusus sesuai kebutuhan area
- Bahan kimia disimpan sesuai standar B3 (label, MSDS tersedia)

4. Alat Pelindung Diri (APD)

APD yang harus tersedia dan digunakan sesuai risiko:

- Sarung tangan (bersih dan heavy duty)
- Masker
- Apron/celemek
- Sepatu kerja tertutup/boot
- Face shield/goggle (bila diperlukan)

5. Fasilitas Pengelolaan Limbah

- Tempat sampah terpilah: Infeksius, Non infeksius, Benda tajam
- Kantong sampah sesuai kode warna
- Troli pengangkut sampah tertutup

6. Standar Penyimpanan

- Alat kebersihan disimpan dalam kondisi bersih dan kering
- Pemisahan alat berdasarkan area (infeksius & non infeksius)
- Bahan kimia disimpan di tempat aman dan terkunci
- Tidak mencampur alat bersih dan kotor

7. Persyaratan K3 dan PPI

- Tersedia MSDS (Material Safety Data Sheet) untuk bahan kimia
- Tersedia fasilitas cuci tangan petugas
- Ventilasi ruangan cukup
- Pencahayaan memadai
- Tersedia prosedur penanganan tumpahan (spill kit jika perlu)

BAB IV

TATA LAKSANA PELAYANAN

4.1 Pembersihan dan Desinfeksi Lingkungan

Pembersihan dan desinfeksi lingkungan merupakan salah satu kegiatan utama Unit Cleaning Service dalam menjaga kebersihan, keamanan, dan mutu lingkungan rumah sakit serta mendukung upaya pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI). Kegiatan ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran, debu, bahan organik, serta menurunkan jumlah mikroorganisme pada permukaan sehingga meminimalkan risiko penularan infeksi kepada pasien, petugas, maupun pengunjung.

Prinsip Dasar Pembersihan dan Desinfeksi

Pelaksanaan pembersihan dan desinfeksi lingkungan harus mengacu pada prinsip-prinsip berikut:

Dilakukan secara rutin, terjadwal, dan insidental (jika terjadi kontaminasi).
Menggunakan metode kerja yang benar, yaitu:
dari area bersih ke area kotor,
dari atas ke bawah,
dari dalam ke luar.
Tidak menimbulkan aerosol (tidak mengibaskan kain/linen).
Menghindari kontaminasi silang dengan penggunaan alat sesuai kode warna.
Menggunakan bahan pembersih dan desinfektan sesuai standar.

2. Klasifikasi Area dan Frekuensi Pembersihan

Pembersihan dan desinfeksi dilakukan berdasarkan klasifikasi risiko area:

Area Risiko Tinggi: ICU, kamar operasi, ruang isolasi, IGD
→ Frekuensi lebih sering (beberapa kali sehari dan setelah tindakan)
Area Risiko Sedang: ruang rawat inap, poliklinik, laboratorium
→ Dilakukan minimal 2 kali sehari atau sesuai kebutuhan
Area Risiko Rendah: kantor, koridor, ruang administrasi
→ Dilakukan minimal 1 kali sehari

Setiap area memiliki standar prosedur dan jenis desinfektan yang disesuaikan dengan tingkat risiko.

3. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan pembersihan dan desinfeksi dilakukan melalui tahapan berikut:

a. Persiapan

Menyiapkan alat kebersihan sesuai area (mop, kain lap, dll)
Menyiapkan bahan pembersih dan desinfektan sesuai kebutuhan
Menggunakan APD sesuai risiko (sarung tangan, masker, apron, dll)
Memastikan alat dalam kondisi bersih dan siap pakai

b. Proses Pembersihan

Membersihkan kotoran kasar terlebih dahulu (debu, sampah)
Membersihkan permukaan menggunakan detergen
Fokus pada high touch surface seperti:
gagang pintu
saklar lampu
pegangan tempat tidur
meja pasien

c. Proses Desinfeksi

Setelah pembersihan, dilakukan desinfeksi menggunakan bahan yang sesuai
Desinfektan digunakan dengan:

konsentrasi yang tepat
waktu kontak (contact time) yang cukup
Area tertentu seperti ruang isolasi memerlukan prosedur khusus
d. Pembersihan Akhir
Memastikan area dalam kondisi bersih dan kering
Membersihkan dan mencuci alat yang digunakan
Melepas APD sesuai prosedur (doffing)
Melakukan hand hygiene
4. Penggunaan Alat dan Kode Warna

Untuk mencegah kontaminasi silang, digunakan sistem kode warna:

Merah: toilet/kamar mandi
Kuning: area infeksius
Hijau: area umum
Biru: area non infeksius

Alat tidak boleh digunakan lintas area tanpa proses pembersihan terlebih dahulu.

5. Penggunaan Bahan Desinfektan
Menggunakan desinfektan yang direkomendasikan (misal: klorin, alkohol, dll)
Disesuaikan dengan jenis permukaan dan risiko
Tidak mencampur bahan kimia tanpa prosedur
Mengikuti petunjuk penggunaan (dosis & waktu kontak)
6. Penerapan PPI dan K3RS

Dalam pelaksanaan kegiatan:

Petugas wajib menggunakan APD sesuai risiko
Melakukan hand hygiene sebelum dan sesudah tindakan
Menghindari paparan bahan kimia dan biologis
Mengikuti prosedur penanganan tumpahan (spill management)
Melaporkan kejadian paparan atau kecelakaan kerja
7. Penanganan Kejadian Khusus
Tumpahan darah/cairan tubuh:
ditutup dengan bahan penyerap
didesinfeksi dengan larutan klorin
Area isolasi:
menggunakan APD lengkap
prosedur khusus sesuai PPI
Wabah/peningkatan kasus infeksi:
frekuensi pembersihan ditingkatkan
8. Monitoring dan Evaluasi
Dilakukan secara berkala melalui:
inspeksi kebersihan
audit kepatuhan petugas
Menggunakan checklist atau indikator mutu
Hasil evaluasi digunakan untuk:
perbaikan SOP
peningkatan mutu pelayanan

4.2 Pengelolaan Sampah Medis dan Non Medis

Pengelolaan sampah medis dan non medis merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan kebersihan dan sanitasi lingkungan rumah sakit yang bertujuan untuk mencegah pencemaran lingkungan, melindungi pasien, petugas, pengunjung, serta masyarakat dari risiko infeksi dan bahaya lainnya. Pengelolaan sampah harus dilakukan secara sistematis, terstandar, dan berkesinambungan sesuai dengan prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) serta keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit (K3RS).

1. Prinsip Dasar Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah di rumah sakit dilakukan dengan prinsip:

Pemilahan sejak dari sumber sesuai jenis sampah
Penggunaan wadah sesuai kode warna dan label
Tidak mencampur sampah medis dan non medis
Pengangkutan menggunakan jalur dan alat khusus
Melindungi petugas dari risiko paparan
Memastikan alur satu arah (tidak terjadi kontaminasi silang)

2. Klasifikasi Sampah Rumah Sakit

Sampah di rumah sakit diklasifikasikan menjadi:

a. Sampah Medis (Infeksius)

Mengandung darah, cairan tubuh, atau bahan infeksius

Contoh: perban bekas, kapas, sarung tangan bekas, alat medis sekali pakai

b. Sampah Non Medis (Domestik)

Tidak terkontaminasi bahan infeksius

Contoh: kertas, plastik, sisa makanan

c. Sampah Benda Tajam

Jarum suntik, ampul, pisau bedah

Berisiko menyebabkan luka tusuk dan infeksi

d. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Mengandung bahan kimia berbahaya

Contoh: sisa bahan kimia, obat tertentu

3. Tahapan Pengelolaan Sampah

a. Pemilahan (Segregasi)

Dilakukan di sumber (ruangan/unit pelayanan)

Menggunakan tempat sampah sesuai kode warna:

Kuning: infeksius

Hitam: non medis

Safety box: benda tajam

Sesuai ketentuan: limbah B3

Wadah harus:

Tertutup

Tidak mudah bocor

Diberi label jelas

b. Pengumpulan

Sampah dikumpulkan secara berkala dari setiap unit

Tidak melebihi kapasitas wadah (maksimal $\pm \frac{3}{4}$ penuh)

Kantong sampah diikat rapat sebelum diangkut

c. Pengangkutan

Menggunakan troli khusus yang tertutup dan mudah dibersihkan

Jalur pengangkutan dipisahkan dari jalur pasien dan makanan

Waktu pengangkutan disesuaikan agar tidak mengganggu pelayanan

d. Penyimpanan Sementara

Sampah ditempatkan di Tempat Penampungan Sementara (TPS)

TPS harus memenuhi syarat:

Tertutup

Mudah dibersihkan

Terpisah antara medis dan non medis

Waktu penyimpanan dibatasi sesuai ketentuan

e. Pengolahan dan Pemusnahan

Dilakukan oleh unit khusus atau pihak ketiga yang berizin

Metode pengolahan:

Insinerasi

Autoclave

Metode lain sesuai regulasi

4. Peran Cleaning Service

Dalam pengelolaan sampah, Cleaning Service bertanggung jawab pada:

Pengumpulan dan pengangkutan sampah dari unit
Menjaga kebersihan wadah dan troli sampah
Memastikan pemilahan sudah sesuai
Melaporkan ketidaksesuaian (misal: salah pemilahan)
5. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

Petugas wajib menggunakan APD sesuai risiko:

Sarung tangan
Masker
Apron/celemek
Sepatu tertutup/boot

APD digunakan untuk mencegah paparan bahan infeksius dan bahan berbahaya.

6. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

Dalam pengelolaan sampah:

Tidak memadatkan sampah dengan tangan
Tidak membuka kembali kantong sampah
Menghindari kontak langsung dengan sampah
Melakukan hand hygiene setelah kegiatan

7. Penanganan Kejadian Khusus

Luka tusuk benda tajam: segera lapor dan lakukan prosedur PEP
Tumpahan limbah infeksius/B3: lakukan spill management
Paparan bahan berbahaya: segera lakukan penanganan sesuai MSDS

8. Monitoring dan Evaluasi

Dilakukan melalui:

Inspeksi rutin
Audit kepatuhan pemilahan
Indikator yang dinilai:
Ketepatan pemilahan
Kepatuhan penggunaan APD
Kebersihan area sampah
Hasil digunakan untuk perbaikan mutu pelayanan

4.3 Pengelolaan Linen Kotor (Handling Awal sebelum Laundry)

Pengelolaan linen kotor merupakan bagian penting dalam sistem kebersihan dan pencegahan serta pengendalian infeksi (PPI) di rumah sakit. Linen yang telah digunakan oleh pasien berpotensi terkontaminasi darah, cairan tubuh, mikroorganisme patogen, serta bahan berbahaya lainnya, sehingga penanganannya harus dilakukan secara benar, aman, dan sesuai standar untuk mencegah penularan infeksi serta melindungi petugas dan lingkungan.

Pengelolaan linen kotor oleh Unit Cleaning Service terbatas pada penanganan awal (handling awal) sebelum linen diproses lebih lanjut oleh unit laundry. Seluruh kegiatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip keselamatan kerja (K3RS) dan pencegahan infeksi.

1. Prinsip Dasar Pengelolaan Linen Kotor

Pengelolaan linen kotor dilakukan dengan prinsip:

Pemisahan linen berdasarkan jenis kontaminasi (infeksius dan non infeksius)
Tidak mengibaskan linen untuk mencegah aerosol mikroorganisme
Meminimalkan kontak langsung dengan linen kotor
Menggunakan wadah tertutup saat pengangkutan
Menghindari kontaminasi silang antara linen kotor dan bersih
Melaksanakan alur satu arah (kotor → laundry)
2. Klasifikasi Linen Kotor

Linen kotor dibedakan menjadi:

Linen non infeksius: linen yang tidak terkontaminasi darah atau cairan tubuh

Linen infeksius: linen yang terkontaminasi darah, cairan tubuh, atau berasal dari pasien infeksius (misalnya TB, COVID-19, dll)

Pemisahan ini sangat penting untuk menentukan metode penanganan dan pengangkutan.

Penanganan Linen Khusus

Linen pasien infeksius (TB, COVID-19, dll):

Ditangani dengan kehati-hatian khusus

Menggunakan APD lengkap

Linen dengan kontaminasi berat (darah/cairan tubuh):

Dipisahkan dan ditangani sesuai prosedur infeksius

4.4 Keselamatan Kerja serta Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

Keselamatan kerja serta pencegahan dan pengendalian infeksi merupakan aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan Cleaning Service di rumah sakit. Petugas Cleaning Service memiliki risiko tinggi terhadap paparan biologis, kimia, maupun fisik, sehingga diperlukan penerapan prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS) serta Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) secara konsisten dan terintegrasi dalam setiap kegiatan pelayanan.

1. Tujuan

Penerapan keselamatan kerja dan PPI bertujuan untuk:

Melindungi petugas dari risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
Mencegah penularan infeksi di lingkungan rumah sakit
Menjamin keamanan pasien, petugas, dan pengunjung
Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat

2. Prinsip Dasar K3RS dan PPI

Pelaksanaan kegiatan harus mengacu pada prinsip:

Mengidentifikasi dan mengendalikan risiko kerja
Menggunakan alat pelindung diri (APD) sesuai risiko
Menerapkan hand hygiene secara konsisten
Mencegah terjadinya kontaminasi silang
Mengikuti prosedur kerja yang aman dan benar
Melaporkan setiap kejadian insiden atau paparan

3. Identifikasi Risiko Kerja

Petugas Cleaning Service berisiko terhadap:

Risiko biologis: paparan darah, cairan tubuh, mikroorganisme
Risiko kimia: paparan bahan pembersih dan desinfektan
Risiko fisik: lantai licin, benda tajam, peralatan kerja
Risiko ergonomi: posisi kerja yang tidak tepat

Identifikasi risiko dilakukan untuk menentukan langkah pencegahan yang sesuai.

4. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

Petugas wajib menggunakan APD sesuai jenis pekerjaan, meliputi:

Sarung tangan
Masker
Apron/celemek

Sepatu tertutup atau sepatu boot
Pelindung mata (goggle/face shield) jika diperlukan

Penggunaan APD harus sesuai prosedur, termasuk cara memakai (donning) dan melepas (doffing) untuk mencegah kontaminasi diri.

5. Penerapan Hand Hygiene

Petugas wajib melakukan hand hygiene:

Sebelum dan sesudah melakukan pekerjaan
Setelah kontak dengan limbah atau bahan terkontaminasi
Setelah melepas APD

Hand hygiene dilakukan sesuai standar yang berlaku menggunakan sabun dan air mengalir atau handrub berbasis alkohol.

6. Prosedur Kerja Aman

Dalam pelaksanaan kegiatan:

Menggunakan alat sesuai fungsi dan standar
Tidak mencampur bahan kimia tanpa prosedur
Menghindari kontak langsung dengan bahan berbahaya
Menggunakan teknik kerja yang aman (tidak mengibaskan linen, tidak memadatkan sampah)
Memasang tanda peringatan (misalnya lantai basah) untuk mencegah kecelakaan
7. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

Upaya PPI meliputi:

Pembersihan dan desinfeksi lingkungan sesuai standar
Pemilahan sampah sesuai jenisnya
Penanganan linen kotor secara benar
Penggunaan alat kebersihan dengan sistem kode warna
Pembatasan penyebaran mikroorganisme melalui teknik kerja yang benar
8. Penanganan Kejadian Insiden

Petugas wajib mengetahui dan melaksanakan prosedur penanganan kejadian, antara lain:

Luka tusuk benda tajam: segera dilakukan pertolongan pertama dan dilaporkan
Paparan darah/cairan tubuh: dilakukan dekontaminasi sesuai prosedur
Paparan bahan kimia: dilakukan penanganan sesuai MSDS
Tumpahan bahan berbahaya: dilakukan spill management

Setiap kejadian harus didokumentasikan dan dilaporkan sesuai alur yang berlaku.

9. Pelatihan dan Edukasi

Petugas Cleaning Service wajib mengikuti pelatihan secara berkala, meliputi:

K3RS
PPI
Penggunaan APD
Penanganan limbah dan linen
Penanganan keadaan darurat

Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kepatuhan petugas.

4.5 Pengelolaan Bahan Pembersih dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pengelolaan bahan pembersih dan bahan berbahaya dan beracun (B3) merupakan bagian penting dalam kegiatan Cleaning Service di rumah sakit, karena penggunaan bahan tersebut berpotensi menimbulkan risiko terhadap kesehatan petugas, pasien, serta lingkungan apabila tidak dikelola dengan benar. Oleh karena itu, diperlukan tata laksana yang terstandar untuk menjamin penggunaan yang aman, efektif, serta sesuai dengan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3RS) dan pencegahan serta pengendalian infeksi (PPI).

1. Tujuan

Pengelolaan bahan pembersih dan B3 bertujuan untuk:

- Menjamin penggunaan bahan pembersih secara aman dan efektif
- Mencegah terjadinya paparan bahan berbahaya pada petugas dan lingkungan
- Menghindari kesalahan penggunaan bahan kimia
- Mendukung kebersihan dan desinfeksi yang optimal

2. Jenis Bahan yang Digunakan

Bahan yang digunakan oleh Cleaning Service meliputi:

- Bahan pembersih (detergen) untuk menghilangkan kotoran
- Desinfektan untuk membunuh mikroorganisme
- Bahan pembersih khusus (kaca, kamar mandi, dll)
- Bahan B3 yang memiliki potensi bahaya seperti korosif, iritatif, atau mudah terbakar

3. Prinsip Pengelolaan Bahan

Pengelolaan bahan dilakukan dengan prinsip:

- Menggunakan bahan sesuai kebutuhan dan fungsi
- Mengikuti petunjuk penggunaan (label dan MSDS)
- Tidak mencampur bahan kimia tanpa prosedur yang jelas
- Menggunakan alat pelindung diri (APD) saat penggunaan
- Menyimpan bahan secara aman dan terpisah

4. Penyimpanan Bahan

Penyimpanan bahan pembersih dan B3 harus memenuhi ketentuan:

- Disimpan di ruang khusus yang aman, tertutup, dan berventilasi baik
- Diberi label yang jelas pada setiap wadah
- Dipisahkan berdasarkan jenis dan tingkat bahaya
- Tidak disimpan bersama bahan makanan atau peralatan medis
- Dilengkapi dengan Material Safety Data Sheet (MSDS)
- Dijauhkan dari jangkauan orang yang tidak berkepentingan

5. Penggunaan Bahan

Dalam penggunaan bahan:

- Petugas wajib membaca label dan mengikuti petunjuk penggunaan
- Menggunakan dosis dan konsentrasi yang sesuai
- Menggunakan APD sesuai risiko (sarung tangan, masker, dll)
- Tidak menggunakan bahan secara berlebihan
- Menghindari kontak langsung dengan kulit dan mata

6. Penanganan Tumpahan (Spill Management)

Apabila terjadi tumpahan bahan:

- Segera lakukan isolasi area
- Gunakan APD lengkap
- Bersihkan tumpahan sesuai prosedur

Gunakan bahan penyerap jika diperlukan
Buang limbah hasil pembersihan sesuai ketentuan
Laporkan kejadian kepada atasan
7. Penanganan Paparan Bahan

Jika terjadi paparan:

Kontak kulit: segera bilas dengan air mengalir
Kontak mata: bilas dengan air bersih dan segera lapor
Terhirup: pindahkan ke area dengan udara segar
Tertelan: segera rujuk sesuai prosedur medis

Penanganan harus mengacu pada informasi yang terdapat dalam MSDS.

8. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

Petugas wajib menggunakan APD saat menangani bahan:

Sarung tangan
Masker
Apron/celemek
Pelindung mata (jika diperlukan)

Penggunaan APD bertujuan untuk mencegah paparan bahan kimia berbahaya.

9. Pelatihan dan Edukasi

Petugas Cleaning Service harus mendapatkan pelatihan terkait:

Penggunaan bahan pembersih dan B3
Pemahaman label dan MSDS
Penanganan tumpahan dan paparan bahan
Keselamatan kerja dalam penggunaan bahan kimia.

BAB V

LOGISTIK

1. Ketentuan Umum

Logistik Unit Cleaning Service merupakan seluruh kebutuhan sarana, prasarana, alat, dan bahan yang digunakan dalam mendukung kegiatan kebersihan, sanitasi lingkungan, serta pengelolaan limbah di rumah sakit. Pengelolaan logistik dilakukan secara efektif, efisien, aman, dan sesuai dengan standar yang berlaku guna menjamin kelancaran pelayanan.

2. Jenis Logistik Cleaning Service

Logistik yang digunakan dalam Unit Cleaning Service meliputi:

a. Peralatan Kebersihan

Troli cleaning service
Mop basah dan kering
Ember dan alat pel
Sapu, pengki, dan alat pembersih debu
Kain lap (berdasarkan kode warna)
Vacuum cleaner (untuk area tertentu)
Alat pembersih kaca
Warning sign (lantai basah)

b. Bahan Pembersih dan Desinfektan

Detergen pembersih lantai
Desinfektan
Pembersih kaca
Pembersih kamar mandi
Bahan pembersih khusus sesuai area

c. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Bahan kimia pembersih tertentu
Desinfektan konsentrasi tinggi
Bahan lain yang memiliki risiko bahaya

d. Alat Pelindung Diri (APD)

Sarung tangan
Masker
Apron/celemek
Sepatu kerja/boot
Pelindung mata (jika diperlukan)

e. Sarana Pendukung

Tempat sampah terpilah (infeksius, non infeksius, benda tajam, B3)
Kantong sampah sesuai kode warna
Troli pengangkut sampah
Tempat penyimpanan alat dan bahan

3. Perencanaan Kebutuhan Logistik

Perencanaan kebutuhan logistik dilakukan berdasarkan:

Luas area pelayanan
Jenis dan tingkat risiko area
Frekuensi kegiatan cleaning service
Jumlah tenaga kerja
Standar penggunaan bahan dan alat

Perencanaan dilakukan secara berkala untuk memastikan ketersediaan logistik sesuai kebutuhan pelayanan.

4. Pengadaan Logistik

Pengadaan logistik dilakukan sesuai dengan ketentuan rumah sakit melalui:

Permintaan dari Unit Cleaning Service

Persetujuan atasan terkait

Pengadaan oleh bagian logistik/pengadaan rumah sakit

Pengadaan harus memperhatikan kualitas, keamanan, dan kesesuaian dengan standar yang berlaku.

5. Penyimpanan Logistik

Penyimpanan logistik dilakukan dengan ketentuan:

Disimpan di ruang khusus yang bersih dan aman

Dipisahkan antara alat bersih dan alat kotor

Bahan kimia dan B3 disimpan terpisah dan diberi label

Dilengkapi dengan MSDS untuk bahan berbahaya

Disusun rapi dan mudah diakses

6. Distribusi dan Penggunaan

Logistik didistribusikan sesuai kebutuhan unit kerja

Penggunaan alat dan bahan harus sesuai SOP

Tidak menggunakan bahan secara berlebihan

Menggunakan sistem pencatatan keluar-masuk barang

7. Pemeliharaan dan Pengendalian

Alat kebersihan dibersihkan setelah digunakan

Dilakukan pemeriksaan berkala terhadap kondisi alat

Penggantian alat dilakukan jika rusak atau tidak layak pakai

Dilakukan pengendalian penggunaan bahan untuk mencegah pemborosan

8. Pencatatan dan Pelaporan

Dilakukan pencatatan penggunaan logistik secara rutin

Meliputi:

Stok masuk dan keluar

Penggunaan bahan

Kondisi alat

Laporan digunakan untuk evaluasi dan perencanaan kebutuhan

9. Keselamatan dalam Pengelolaan Logistik

Petugas wajib menggunakan APD saat menggunakan bahan

Tidak mencampur bahan kimia tanpa prosedur

Mengikuti petunjuk penggunaan bahan

Menyimpan bahan berbahaya sesuai standar K3RS.

BAB VI

KESELAMATAN PASIEN DAN PETUGAS

Keselamatan pasien dan petugas merupakan prioritas utama dalam penyelenggaraan pelayanan Unit Cleaning Service di rumah sakit. Kegiatan cleaning service yang meliputi pembersihan lingkungan, pengelolaan limbah, dan penanganan linen memiliki potensi risiko terhadap pasien, petugas, maupun pengunjung apabila tidak dilakukan sesuai standar. Oleh karena itu, diperlukan penerapan prinsip keselamatan pasien dan keselamatan kerja secara konsisten dan terintegrasi.

1. Tujuan

Penerapan keselamatan pasien dan petugas bertujuan untuk:

- Mencegah terjadinya cedera dan insiden yang tidak diharapkan
- Mengurangi risiko penularan infeksi
- Melindungi petugas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
- Menjamin lingkungan rumah sakit yang aman dan nyaman

2. Prinsip Keselamatan Pasien

Dalam pelaksanaan pelayanan Cleaning Service, keselamatan pasien dilakukan dengan:

- Menjaga kebersihan lingkungan secara optimal untuk mencegah infeksi
- Menghindari kontaminasi silang dari alat, bahan, dan petugas
- Menggunakan bahan pembersih yang aman dan sesuai standar
- Memastikan area pelayanan bebas dari bahaya seperti lantai licin
- Memasang tanda peringatan (warning sign) saat proses pembersihan

3. Prinsip Keselamatan Petugas

Keselamatan petugas dilakukan dengan:

- Mengidentifikasi dan mengendalikan risiko kerja
- Menggunakan alat pelindung diri (APD) sesuai jenis pekerjaan
- Mengikuti prosedur kerja yang aman dan benar
- Menghindari paparan bahan berbahaya dan mikroorganisme
- Mengikuti pelatihan K3RS dan PPI secara berkala

4. Identifikasi Risiko

Risiko yang dapat terjadi pada kegiatan Cleaning Service meliputi:

- Risiko biologis: paparan darah, cairan tubuh, mikroorganisme
- Risiko kimia: paparan bahan pembersih dan B3
- Risiko fisik: terpeleset, tertusuk benda tajam, terbentur
- Risiko ergonomi: kelelahan akibat posisi kerja

Identifikasi risiko dilakukan untuk menentukan langkah pencegahan yang tepat.

5. Pencegahan Insiden

Upaya pencegahan dilakukan melalui:

Penerapan standar operasional prosedur (SOP)
Penggunaan APD sesuai indikasi
Penerapan hand hygiene
Pemisahan alat dan bahan berdasarkan area
Penggunaan alat sesuai fungsi
Penempatan tanda peringatan di area berisiko
6. Penanganan Insiden

Apabila terjadi insiden, dilakukan langkah sebagai berikut:

Memberikan pertolongan pertama
Melaporkan kejadian kepada atasan
Mencatat dalam formulir insiden keselamatan
Melakukan evaluasi dan tindak lanjut
Mencegah kejadian berulang

BAB VII

KESELAMATAN KERJA

7.1 Pengertian

Keselamatan kerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pelayanan Unit Cleaning Service di rumah sakit. Kegiatan cleaning service memiliki potensi risiko tinggi terhadap kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, baik yang bersumber dari faktor biologis, kimia, fisik, maupun ergonomi. Oleh karena itu, penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS) wajib dilaksanakan secara konsisten untuk melindungi petugas serta mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat.

7.2 Tujuan

Penerapan keselamatan kerja bertujuan untuk:

- Melindungi petugas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
- Mencegah terjadinya insiden yang dapat membahayakan pasien dan lingkungan
- Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan petugas terhadap prinsip K3RS
- Menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif

7.3 Prinsip Keselamatan Kerja

Pelaksanaan keselamatan kerja dilakukan dengan prinsip:

Identifikasi dan pengendalian risiko kerja
Kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP)
Penggunaan alat pelindung diri (APD) sesuai risiko
Penerapan teknik kerja yang aman
Pelaporan dan penanganan insiden secara cepat dan tepat.

7.4 Identifikasi dan Klasifikasi Risiko Kerja

Risiko kerja pada Unit Cleaning Service meliputi:

a. Risiko Biologis

Paparan darah, cairan tubuh, mikroorganisme dari limbah medis dan linen kotor.

b. Risiko Kimia

Paparan bahan pembersih dan bahan berbahaya dan beracun (B3) seperti desinfektan.

c. Risiko Fisik

Terpeleset akibat lantai basah, tertusuk benda tajam, terbentur, atau terkena alat kerja.

d. Risiko Ergonomi

Kelelahan akibat posisi kerja yang tidak ergonomis atau aktivitas berulang.

7.5 Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja

Upaya pencegahan dilakukan melalui:

- Penerapan SOP dalam setiap kegiatan
- Penggunaan APD sesuai jenis pekerjaan
- Pemasangan tanda peringatan (misalnya lantai basah)
- Penggunaan alat kerja yang sesuai dan aman
- Pemeliharaan alat secara berkala
- Pengaturan beban kerja yang sesuai

7.6 Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

Petugas wajib menggunakan APD sesuai risiko pekerjaan, meliputi:

- Sarung tangan
- Masker
- Apron/celemek
- Sepatu tertutup atau sepatu boot
- Pelindung mata (jika diperlukan)

Penggunaan APD harus sesuai prosedur, termasuk cara memakai dan melepas yang benar untuk mencegah kontaminasi.

7.7 Prosedur Kerja Aman

Dalam pelaksanaan pekerjaan:

- Tidak mencampur bahan kimia tanpa prosedur
- Tidak memadatkan sampah dengan tangan
- Tidak mengibaskan linen kotor
- Menggunakan alat sesuai fungsi
- Menjaga posisi kerja yang ergonomis
- Menghindari tindakan yang berisiko

7.8 Penanganan Kejadian Kecelakaan Kerja

Apabila terjadi kecelakaan kerja:

- Segera lakukan pertolongan pertama
- Laporkan kepada atasan atau penanggung jawab
- Catat dalam formulir kejadian kecelakaan kerja
- Lakukan tindak lanjut sesuai prosedur K3RS
- Evaluasi untuk mencegah kejadian berulang

7.9 Penanganan Keadaan Darurat

Petugas harus memahami dan mampu menangani kondisi darurat seperti:

- Kebakaran
- Tumpahan bahan berbahaya (spill)
- Paparan bahan kimia
- Bencana alam

Penanganan dilakukan sesuai prosedur tanggap darurat yang berlaku di rumah sakit.

BAB VIII

PENGENDALIAN MUTU

Pengendalian mutu kebersihan lingkungan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk memastikan bahwa seluruh area rumah sakit tetap dalam kondisi bersih, higienis, aman, serta memenuhi standar kesehatan lingkungan. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mendukung pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI), keselamatan dan kesehatan kerja (K3RS), serta peningkatan mutu pelayanan rumah sakit.

1. Tujuan Pengendalian Mutu

Pengendalian mutu kebersihan lingkungan bertujuan untuk:

- Menjamin kebersihan lingkungan rumah sakit sesuai standar
- Menurunkan risiko infeksi terkait lingkungan
- Memastikan kepatuhan petugas terhadap SOP
- Mengidentifikasi permasalahan dan melakukan perbaikan berkelanjutan
- Mendukung pencapaian indikator mutu rumah sakit

2. Prinsip Dasar Pengendalian Mutu

Pengendalian mutu dilakukan dengan prinsip:

- Terukur melalui indikator yang jelas
- Objektif berdasarkan hasil observasi dan data
- Berkesinambungan (continuous improvement)
- Terintegrasi dengan program PPI, K3RS, dan PMKP
- Terdokumentasi dan dapat ditelusuri

3. Komponen Pengendalian Mutu

a. Standar Kebersihan Lingkungan

Penilaian kebersihan dilakukan berdasarkan standar yang telah ditetapkan, meliputi:

- Kebersihan lantai, dinding, dan permukaan
- Kebersihan fasilitas umum (toilet, wastafel)
- Kebersihan area berisiko tinggi (ICU, OK, isolasi)
- Tidak adanya debu, kotoran, atau bau tidak sedap
- Kondisi alat kebersihan yang higienis

b. Indikator Mutu

Pengendalian mutu menggunakan indikator yang dapat diukur, seperti:

- Tingkat kepatuhan pembersihan sesuai jadwal
- Kepatuhan penggunaan APD oleh petugas
- Ketepatan pemilahan sampah
- Kepatuhan penggunaan kode warna alat
- Hasil audit kebersihan lingkungan

c. Monitoring dan Audit

Monitoring dilakukan secara rutin melalui:

- Inspeksi harian oleh penanggung jawab
- Audit berkala oleh tim terkait (PPI/PMKP)

Observasi langsung di lapangan
Penggunaan checklist atau lembar observasi

Audit bertujuan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan dengan standar yang berlaku.

4. Metode Penilaian Kebersihan

Penilaian kebersihan dilakukan dengan metode:

Observasi visual terhadap kondisi lingkungan
Checklist audit kebersihan
Pengukuran parameter lingkungan (jika diperlukan)
Umpan balik dari unit pelayanan atau pengguna layanan

Hasil penilaian dapat dikategorikan menjadi baik, cukup, atau kurang sesuai standar yang ditetapkan.

5. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Hasil monitoring dan audit harus ditindaklanjuti melalui:

Perbaikan langsung terhadap temuan
Pembinaan dan pelatihan petugas
Revisi prosedur bila diperlukan
Peningkatan frekuensi pembersihan pada area tertentu
Koordinasi dengan unit terkait

6. Dokumentasi dan Pelaporan

Seluruh kegiatan pengendalian mutu harus didokumentasikan, meliputi:

Hasil audit dan monitoring
Rekapitulasi indikator mutu
Laporan ketidaksesuaian
Tindak lanjut perbaikan

Laporan disampaikan secara berkala kepada manajemen sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan.

7. Peran dan Tanggung Jawab

Petugas Cleaning Service: melaksanakan pembersihan sesuai SOP
Penanggung Jawab Cleaning Service: melakukan supervisi dan monitoring
Tim PPI: memberikan arahan terkait pencegahan infeksi
Tim PMKP: melakukan evaluasi mutu dan indikator
Manajemen RS: menetapkan kebijakan dan dukungan sumber daya

8. Integrasi dengan PPI dan K3RS

Pengendalian mutu kebersihan lingkungan terintegrasi dengan:

Program PPI untuk mencegah infeksi terkait lingkungan
Program K3RS untuk menjamin keselamatan petugas
Program PMKP untuk peningkatan mutu berkelanjutan

BAB IX

PENUTUP

Pedoman Pelayanan Unit Cleaning Service Rumah Sakit Prima Husada ini disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan kegiatan kebersihan, sanitasi lingkungan, pengelolaan limbah, serta penanganan linen di rumah sakit agar dapat berjalan secara terarah, terkoordinasi, dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Dengan adanya pedoman ini diharapkan seluruh petugas Cleaning Service mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, efisien, serta konsisten dalam menerapkan prinsip keselamatan kerja, pencegahan dan pengendalian infeksi, serta keselamatan pasien di lingkungan rumah sakit.

Pedoman ini juga menjadi dasar dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan peningkatan mutu pelayanan Cleaning Service secara berkelanjutan, guna mendukung terciptanya lingkungan rumah sakit yang bersih, aman, dan nyaman bagi pasien, petugas, maupun pengunjung.

Pedoman ini akan dilakukan peninjauan dan evaluasi secara berkala sesuai dengan perkembangan kebijakan, peraturan perundang-undangan, serta kebutuhan pelayanan rumah sakit guna meningkatkan mutu pelayanan Unit Cleaning Service Rumah Sakit Prima Husada.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 5 Juni 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



dr. Nur Mazidah